

MEDICACIÓN ESENCIAL EN PALIATIVOS

Silvia García Martínez, Álvaro González de Diego, Valentin Riaño Zalbidea

Fármaco	Tipo y nombre comercial	Indicación	Contraindicación	Efectos secundarios	Posología
AMITRIPTILINA	Antidepresivo tricíclico. Tryptizol®, Deprelío®.	Depresión. Dolor neuropático.	IAM reciente. Uso concomitante de IMAO.	Sedación, hipotensión ortostática, efectos anticolinérgicos (xerostomía, RAO, estreñimiento, visión borrosa).	(Depresión) De inicio: 30-75mg vo/24h (acostarse). Máx. 150/24h. (Dolor neuropático) 25-75mg vo/24h, Máx.150mg/24h. (Ambos) ↑ Gradual.
BISACODILO	Laxante. Dulcolaxo® (cp; supo).	Estreñimiento.	Hemorroides o fisura anal (rectal). Obstrucción intestinal.	Dolor y distensión abdominal.	5-10mg vo/24h (noche). 10mg rectal/24h (mañana).
BUTILESCOPOLAMINA	Espasmolítico. Buscapina®.	Estertores agónicos. Dolor espasmódico intestinal y de vías urinarias.	RAO. Obstrucción intestinal. Estenosis pilórica. Miastenia.	Anticolinérgicos (xerostomía). Taquicardia.	10-20mg vo, sc o iv cada 6-8h. D. Máx. 100mg/24h.
CARBAMAZEPINA	Antiepiléptico. Tegretol®.	Dolor neuropático (lancinante, paroxístico).	BAV. Aplasia medular. Porfiria hepática. Uso de IMAO.	Somnolencia y ataxia (más frecuentes). Aplasia medular (más graves). Erupciones cutáneas.	(Inicio) 200-400mg vo cada 24h. Aumento gradual. (Dosis mínima eficaz) 400-800mg/24h.
CITALOPRAM	Antidepresivo ISRS.	Depresión.	Prolongación QT. Uso de IMAO.	Náuseas, xerostomía, anorexia. Mialgias. Hiperhidrosis. Insomnio/somnolencia. ↓ Libido. Hiponatremia. Prolongación del QT.	(Inicio) 20mg vo/24h. ↑ Gradual en 2 semanas. D. Máx. 40mg vo/24h.
CODEÍNA	Antitusígeno central, opioide menor. Codeisan®.	Tos seca. Dolor. Diarrea.	Íleo paralítico. Diarrea infecciosa o por intoxicación.	Estreñimiento, xerostomía, RAO.	(Tos) 28,7mg/6h vo. (Dolor) 28,7mg/6h vo, D. Máx. 240mg/24h.
DEXAMETASONA	Corticoide. Fortecortin®.	Indicación: Anorexia. Náuseas y vómitos. Oclusión intestinal maligna. Dolor neuropático. Infiltración/compresión nerviosa o medular. Edema cerebral. Hipercalcemia tumoral.	(Uso prolongado): Hiper glucemia/diabetes esteroidea, Síndrome Cushing, miopatía esteroidea, HTA, hiperfagia, euforia, osteoporosis y fracturas.	Según indicación: (Edema cerebral) iv,sc,im. Bolo de 8mg y después 4mg/6-8h. (Oclusión) iv,sc. 4-12mg/24h.	
DIAZEPAM	Benzodiazepina Valium®	Ansiedad. Crisis comiciales. Estatus. Mioclonias.	Miastenia gravis.	Somnolencia. Vértigo. Ataxia.	(Ansiedad) 2-10mg vo/6-12h. (Estatus) 0,15-0,25mg/kg/10-15 min iv., máx 3mg/kg/24h.
DICLOFENACO	AINE. Voltaren®.	Dolor leve a moderado. (Dolor metástasis óseas).	Úlcera gástrica o duodenal. Hemorragia digestiva. IC. I. Renal o hepática severa.	Dispepsia. Úlcera gástrica o duodenal. Cefalea. HTA. ↓ Filtrado gomerular.	(Normal) 50mg vo/8-12h. (Retard) 75-150mg vo/24h. 100mg rectal/24h.
FENTANILO	Opioide. Fendivia®, Actiq®, Effentora®, Abstral®.	Dolor crónico moderado a severo.	Depresión respiratoria grave.	Náuseas, vómitos, estreñimiento. Mareo, somnolencia. Depresión respiratoria.	Transdérmico: (Inicio) 12-25µg/72h. Bucal (buc, sl): Según presentación. Consultar.

Fármaco	Tipo y nombre comercial	Indicación	Contraindicación	Efectos secundarios	Posología
GABAPENTINA	Antiepiléptico. Neurontin®.	Dolor neuropático.	Alergia.	Somnolencia, mareo, ataxia, astenia.	(1º día) 300mg vo/24h, (2º día) 300mg/12h, (3º día) 300mg/8h. Después, ↑ 300mg/3 días hasta máx 3600mg/día (en 3 tomas).
HALOPERIDOL	Antipsicótico.	Agitación. Hipo. Vómitos.	Parkinson.	Extrapiramidales (Parkinsonismo, acatisia, distonía y discinesia tardía).	0,5-2mg vo/8-12h. 5-10mg /12-24h im (en casos graves, hasta cada 6h).
IBUPROFENO	AINE Neobrufen®	Dolor leve a moderado.	Últera gástrica o duodenal. Hemorragia digestiva. IC. Coagulopatía.	Dispepsia. Úlcera gástrica o duodenal. Cefalea. HTA.	400-600mg vo/6-8h.
LEVOMEPRAMACINA	Neuroleptico. Sinogan®	Delirium	Agranulocitosis, porfiria. Levodopa. Ingestión alcohol.	Somnolencia. Anticolinérgicos. Extrapiramidalismo.	25-50mg vo/24h, en 2-4 tomas, y ↑ hasta 100-200/24h. 25-50mg sc,im/6-8h.
LOPERAMIDA	Antidiarreico. Fortasec®	Diarrea (no infecciosa)	Obstrucción intestinal. Diarrea infecciosa.	Raros. Uso prolongado. Digestivos.	(Inicio) 4mg vo. (Después) 2mg tras cada deposición. D. Máx. 16mg vo/24h.
LORAZEPAM	Benzodiazepina Orfidal®	Ansiedad. Insomnio.	Miastenia. I. respiratoria, hepática severa.	Sedación residual. Somnolencia.	(Ansiedad) 0,5-1mg vo/8-12h. (Insomnio) 1-2 mg vo al acostarse.
ACETATO DE MEGESTROL	Antineoplásico progestágeno. Borea®	Anorexia. Caquexia.		Náuseas. Vómitos. Pirosis.	(Inicio) 160mg vo/24h. (D. habitual) 320-800 mg vo / 24h. (D.Máx.) 800mg vo/24h.
METOCLOPRAMIDA	Antiemético y procinético. Primperan®.	Náuseas, vómitos.	Parkinson. L-dopa. Discinesia tardía por neurolepticos. Epilepsia. Feocromocitoma. Obstrucción / perforación intestinal.	Extrapiramidalismo. Somnolencia. Diarrea. Hipotensión.	10mg vo/8h. 10mg iv,im,sc/8h.
MIDAZOLAM	Benzodiazepina Dormicum®	Agitación, ansiedad. Sedación. Hipnótico.	Apneas del sueño. Miastenia. I. respiratoria severa. I. hepática grave.	Sedación, somnolencia.	(Hipnótico) 7,5mg vo al acostarse. (Ansiedad y agitación) 2,5-7,5mg sc/6-8h. (Sedación) Ver capítulo correspondiente
MIRTAZAPINA	Antidepresivo. Rexer®	Depresión	Tto con IMAO (actual o en últimos 14 días)	Xerostomía, náuseas. Somnolencia, cefalea, mareo. SIADH. ↑ Peso. Polifagia.	15-30mg vo/24h. ↑ cada 2-4 semanas. (D.Máx.) 45mg/24h.
MORFINA** (Ver detalles en capítulo correspondiente)	Opioide mayor. MST continus® Sevredol® M. BRAUN® M. SERRA®	Dolor moderado-severo. Disnea.	Insuficiencia respiratoria grave. IMAO.	Náuseas, xerostomía, estreñimiento. RAO. Somnolencia, desorientación.	(Lib. inmediata) 5-10mg vo/4h. (Titular y rescates). (Lib. retardada) 10-30mg vo/12h. (Tto base) (iv,sc. Ver capítulo correspondiente)

Fármaco	Tipo y nombre comercial	Indicación	Contraindicación	Efectos secundarios	Posología
OCTREÓTIDO	Análogo sintético de somatostatina. Sandostatin®	Diarrea. Vómitos.		Diarrea, dolor y distensión abdominal, náuseas, estreñimiento. Colelitiasis. Bradicardia. Cefalea. Hiperglucemia.	0.2-0.9mg sc/24h
OXICODONA	Opioide mayor. Oxynorm® Oxycontin® Targin® (+ naloxona)	Dolor moderado a severo	Insuficiencia respiratoria grave. Íleo paralítico. IMAO.	Náuseas, xerostomía, estreñimiento. RAO. Somnolencia, desorientación. Prurito.	(Lib. inmediata) 5mg vo /4-6h; 2.5mg sc,iv/6h. (Titular y rescates). (Lib. retardada) 5-10mg vo/12h. (Tto base) (Infusión continua iv,sc) 10mg/24h. (Naloxona) 5/2.5mg vo/12h.
PARACETAMOL	Analgésico. Gelocatil® Efferalgan®	Dolor leve moderado	Hepatopatía severa.	Toxicidad hepática (uso prolongado/sobredosis).	500mg-1g vo o iv/6-8h D. Máx: 4g/24h.
TRAMADOL	Opioide menor. Adolonta®.	Dolor leve moderado	Intoxicación etílica o por psicofármacos. IMAO.	Mareo, vértigo, vómitos náuseas, hipotensión, sudoración, xerostomía.	50-100mg vo/6-8h 50-100mg iv,sc,im/6-8h
TRAZODONA	Antidepresivo. Deprax®	Insomnio	IAM reciente. Uso concomitante de IMAO.	Somnolencia, náuseas.	50-150mg vo/24h (al acostarse). ↑ en 50mg/24h, cada 4días. (D. Máx.) 400mg/24h.
ZOLPIDEM	Hipnótico. Stilnox®	Insomnio	I. respiratoria grave. Miastenia.	(Dosis dependiente) Somnolencia, cefalea, mareo.	5-10mg vo/24h (al acostarse).

ALGUNAS CONSIDERACIONES

- *Todos los fármacos están contraindicados en caso de hipersensibilidad (HS).
- **La MORFINA, al igual que el resto de opioides, son fármacos fundamentales en los cuidados paliativos, especialmente en el control del dolor. La descripción de sus características farmacológicas, presentaciones y modo de empleo son amplias y complejas, mereciendo un análisis detallado, inviable en este capítulo. Por ello, remitimos al capítulo correspondiente.
- ***Abreviaturas:
 - I. = Insuficiencia.
 - D. Máx.= Dosis máxima.
 - Lib. = Liberación.
 - Vo = vía oral;
 - iv= intravenoso;
 - im= intramuscular;
 - sc= subcutáneo.
 - HS= Hipersensibilidad.

- ↑ = Aumentar, incremento.
- Cp= comprimido.
- Supo=supositorio.
- Sd.= Síndrome.
- Buc=Comprimidos que se colocan en/desplazan por la mucosa bucal. sl=Comprimidos sublinguales.
- Tto= Tratamiento.
- ↓ =Disminuir.
- ****En los fármacos en los que está contraindicado el uso concomitante de IMAO, suele ser necesario haber suspendido 15 días antes el IMAO. Consultar cada caso de forma particular.

BIBLIOGRAFÍA

- IAHP: Essential medicines for palliative care [Internet]. Disponible en: <https://hospicecare.com/uploads/2011/8/iahpc-list-em-sp.pdf>
- Villa L.F. y cols. Medimecum. Guía de terapia farmacológica. 22ªEd. España: Springer Healthcare; 2017.
- Agencia Española del Medicamento. Centro de información online de medicamentos de la AEMPS (CIMA). Disponible en: <https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html>.
- Porta Sales J., Gómez Batiste X., Tuca Rodríguez A. Manual. Control de síntomas en paciente con cáncer avanzado y terminal. 3ªEd. España: Grünenthal pharma S.A. 2013.